DEVENIR FONCTIONNEL DE LA PARALYSIE CEREBRALE REEDUQUEE AU CHU SOURO SANOU DE BOBO-DIOULASSO

Nom du présentateur : Dr Salifou GANDEMA

Auteurs et coauteurs : Gandema S, Belem B.P, Nikiéma G, Tiaho Y.

Affiliations : 1. Service de MPR, CHU Sourô Sanou de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats / Discussion
- Conclusion

Introduction

- Trouble du développement moteur et du comportement
- Première cause de handicap physique non traumatique de l'enfant
- Prévalence 2‰ naissances: problème de santé publique
- Peu d'études sur les interventions thérapeutiques
- Intérêt: évaluer le devenir fonctionnel, suite de rééducation motrice.

Objectif

Etudier le devenir fonctionnel des enfants paralysés cérébraux pris en charge dans le service de MPR du CHUSS du 01 Janvier 2016 au 31 Décembre 2017

Matériel et méthode(s)

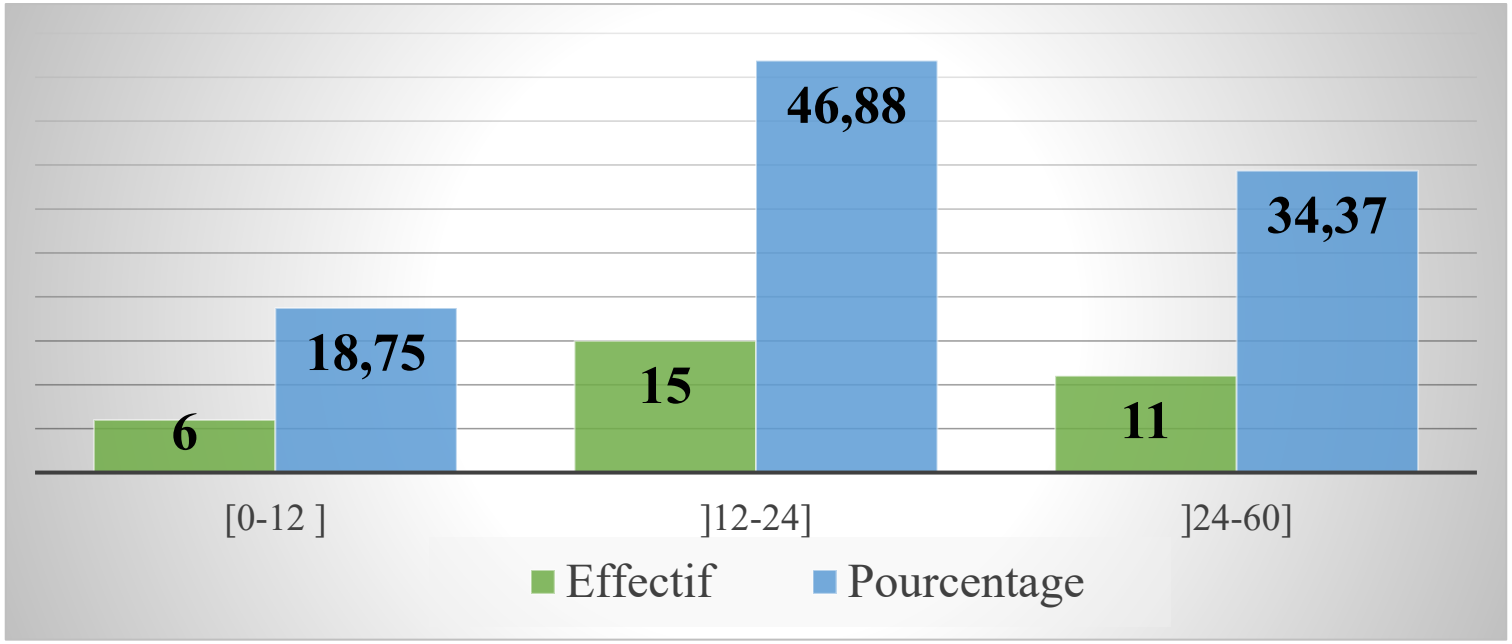
- Etude descriptive et analytique à collecte rétrospective
- 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017
- Population cible: enfants de 0 à 5 ans, PC, traités au CHUSS.
- Variables: socio-démographiques, cliniques, fonctionnels.
- Echelles d'évaluation fonctionnelle: **GMFCS**
  MACS
  EDACS

Résultats/Discussions

- **Données socio-démographiques:**
  - 1763 patients admis dans le service
  - 234 atteints de paralysie cérébrale
  - 32 patients inclus
  - Prévalence relative: 13,27%. [**Nguefack: 18%; Sanou: 21%**]
  - 25 décès enregistrés, soit 17,24%. [**Lukia: 29%; Jahan: 19%**]

Résultats /Discussions

- **Age moyen**: 26,90 mois [**Touré: 27,2; Doumbia: 33,33%**]



Résultats /Discussions

- **Sexe**:
  - Prédominance masculine 68,75% ; sex-ratio: 2,2
  - Touré : sex-ratio: 1,38
  - Doumbia: sex-ratio: 2,1

Sexe masculin: facteur favorisant?

Sexe féminin: Facteur protecteur (oestroprogestatifs)

[Johnston USA 2007]

Résultats /Discussions

- **Education scolaire**

- Taux de scolarisation: 43,75% contre 6% [Sanou 2012]
- Difficultés scolaires: multiples redoublements (50%)

- **Absence d'établissements d'enseignement spécialisés**

- **Inadéquation des enseignements /capacités intellectuelles**

- **=> Développer l'éducation inclusive**

Résultats /Discussions

- 71% des patients vivent avec leurs parents
- Taille de la fratrie: 4 enfants en moyenne contre 2 au Mali [**Touré**]
- Divorces: **63,64%**
- Tensions: 18,18%
- **Grande fratrie: milieu favorable mais cache l'abandon du PC**
- **Altération de la qualité de vie du couple.**

Résultats /Discussions

- **Profession des parents**
- Profession du père: 56,25%: secteur informel
- Profession mère: 68,75%: femme au foyer (occupée par le PC)

- Les mères sont plus touchées

Résultats /Discussions

- **Profil clinique:**
- Tétraplégie: 46,88%; [Doumbia: 33,8; Elkhoti: 22,9%]
- Hypertonie: 46,87% [Fondation PC : 60%]
- Comitialité: 21,88%
- Troubles du langage: 25%
- **Polymorphisme des lésions cérébrales; Potentiel incapacitant.**

Résultats /Discussions

- **Devenir fonctionnel**
- Troubles sévères de marche: 43,75%
- Perte de l'habileté manuelle: 18,75%
- Dépendance alimentaire: 34,38%
- **Cachexie chez la majorité des patients.**

Résultats /Discussions

- **Dépendance fonctionnelle**
- Dépendance totale: 28,13%
- Besoin d'assistance humaine permanente: 71,88%

[Dziri: 72%; Touré [50%]

- **Absence de structure d'accueil spécialisée**
- **Difficultés dans le couple**

Conclusion

- PC: problème majeur de santé publique, non par sa fréquence mais par son potentiel incapacitant et son poids psycho-social.
- Nécessité de développer le volet préventif de cette pathologie
- Améliorer la qualité de la prise en charge en termes d'élévation des plateaux techniques des hôpitaux, la formation du personnel que le développement des structures d'accueil socio-éducatives.

Merci de votre attention

- Gross Motor Function Classification System for Cerebral Palsy (**GMFCS**).
- Le Manual Ability Classification System (**MACS**).
- Eating and Drinking Ability Classification System (**EDACS**),